

Тейпы: виды, как работают и когда их использовать

ИСТОЧНИК

Тейпы уже давно стали привычным предметом в арсенале многих бегунов, ски-альпинистов, лыжников. Разбираемся, как они работают, и как правильно их использовать.

Автор

Дарья Сенькина - профессиональный спортсмен сборной России по ски-альпинизму, МС по альпинизму в классе "скайраннинг". Летом бегаёт скайраннинг-гонки. Действующий практикующий врач травматолог-ортопед.

Тейпирование, как использование повязок для фиксации повреждённых и укрепления ослабленных участков тела в спорте, известно ещё со времен Древней Греции. Но основное развитие и начало изготовления профессиональных спортивных тейпов и сопутствующих материалов было положено американским врачом Вирджилом Гибли, который первым описал основные схемы наложения аппликаций для фиксации голеностопных суставов с помощью неэластичных клейких лент – тейпов – в конце XIX в., а также нашим соотечественником, иммигрировавшим в 1911 г. в США, Самуэлем Билыком. Затем эта методика получила широкое распространение среди спортивных врачей в других странах.

В настоящий момент большинство как зарубежных, так и отечественных специалистов выделяют основные три разновидности и методики тейпирования:

Атлетическое (спортивное) жесткое тейпирование – методика наложения специально разработанного неэластичного или эластичного тейпа, возникшая раньше всех других, позволяющая создать условия для ограничения подвижности/стабилизации или уменьшения/исчезновения объема патологических движений в суставах нижних и верхних конечностей посредством фиксации нескольких его слоев на поверхностных тканях.

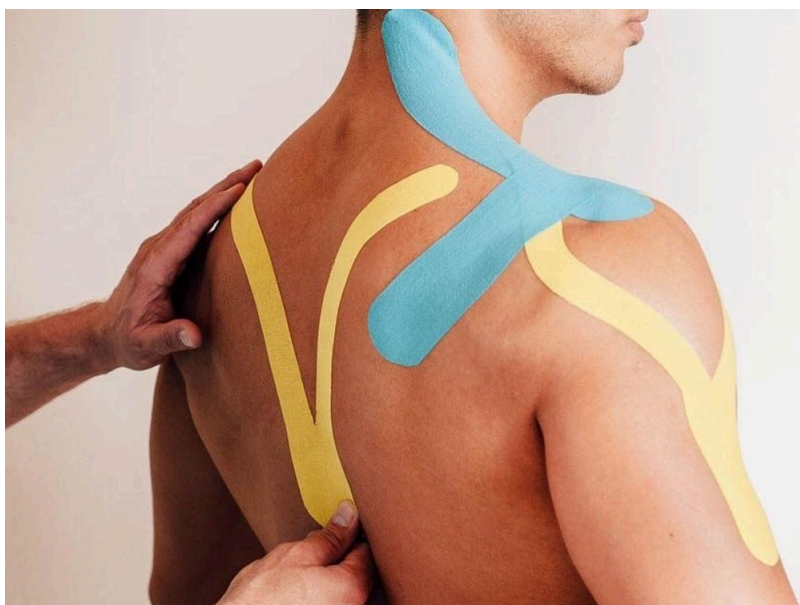


Спортивный тейп - специально разработанный неэластичный или эластичный пластырь, выполненный из 100% хлопковой ткани и иногда эластического полимера, с нанесенным на него клеящим слоем с одной стороны.



Терапевтическое жесткое тейпирование – это совокупность навыков и приемов для выполнения аппликаций специально разработанным неэластичным тейпом на кожных покровах, которые способны оказывать предсказуемое влияние на различные моторные стереотипы и положение отдельных частей или целых суставов, предположительно через воздействие непосредственно на покровные ткани тела и их смещения или фиксации.

Кинезиологическое (эластическое) тейпирование – наиболее популярный и широко применяемый в реабилитационной медицине, спорте и косметологии – это совокупность навыков и приемов для выполнения аппликаций специально разработанным эластическим пластырем на кожных покровах, которые способны оказывать предсказуемое влияние на различные моторные стереотипы, посредством воздействия непосредственно на покровные ткани тела и их рецепторный аппарат, а также оптимизировать течение локального воспалительного процесса за счёт снижения внутритканевого давления, а значит, обеспечения адекватного обстоятельствам уровня микроциркуляции и лимфодренажа.



Поговорим подробнее об этом методе:

Материал для тейпирования

Кинезиологические тейпы представляют собой эластичные клейкие ленты (пластыри), выполненные из 100% хлопка и покрытые гипоаллергенным клеящим слоем на акриловой основе, который активизируется при температуре тела. Обладают толщиной и эластичностью сходными по свойствам с поверхностным слоем человеческой кожи (эпидермисом), что позволяет избежать излишней сенсорной стимуляции при правильном наложении, т.е. через 10 минут после нанесения аппликации пациент перестает ее ощущать. Хлопковая основа тейпов способствует лучшему испарению и дыханию кожи, а также быстрому высыханию тейпа. На примере классического кинезиологического тейпа ниже описаны основные свойства качественного кинезиотейпа, с которым рекомендуется выполнять аппликации.

Классический кинезиологический тейп изготовлен из 100% хлопка и включает волокна эластического полимера (спантекс), которые и обуславливают его растяжимость. Кинезиологический тейп нанесен на бумажную подложку, которая разлинована на 5 продольных полос по длине (с целью облегчения нарезания аппликации для микроциркуляторной коррекции) и на пятисантиметровые квадраты по ширине (с целью облегчения измерения полоски кинезиологического тейпа для аппликации). Так же на бумажной подложке может быть размещена информация о фирме-производителе и его логотипы и товарные знаки. Важным компонентом классических кинезиологических тейпов является заводская степень натяжения тейпа, нанесенного на бумажную подложку, которая равна 10%. Эластичность кинезиологического тейпа составляет 40-60% от его изначальной длины и зависит от ширины исходной полоски кинезиологического тейпа. Существуют рулоны классических кинезиологических тейпов шириной 1 см, 2,5 см, 5 см, 7,5 см и 10 см.

Механизм действия кинезиотейпов

В основе лечебного действия тейпов лежат следующие эффекты:

1. Активация микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке.
2. Уменьшение болевого синдрома.
3. Восстановление функциональной активности мышц.
4. Нормализация функции суставов.

1. Активация микроциркуляции

Наложённый на поверхность кожи тейп, предварительно растянутый до 50% длины, несколько приподнимает верхние слои кожи, что создает благоприятные условия для активации микроциркуляции в соединительной ткани и межклеточном веществе, что способствует выводу продуктов метаболизма и улучшению лимфотока.

2. Уменьшение болевого синдрома

Уменьшение болевого синдрома реализуется за счет двух механизмов: 1) активации афферентного (обратного) потока через волокна нервных окончаний; 2) улучшения микроциркуляции в соединительной ткани. Болевой синдром возникает вследствие раздражения ноцицепторов (болевых рецепторов), представляющих собой свободные нервные окончания, наибольшее количество которых расположено в верхних слоях кожных покровов. В соответствии с теорией «воротного контроля» болевой импульс подавляется импульсом, приходящим от тактильных и барорецепторов. Тейп, наложенный на поверхность кожи, раздражает прежде всего тактильные рецепторы и барорецепторы, от которых обратный сигнал поступает в задние рога спинного мозга, подавляя

болевой импульс, таким образом уменьшая болевой синдром. Второй механизм реализуется при активации микроциркуляции: медиаторы воспаления повышают чувствительность рецепторов, а тейп способствует их выведению за счет декомпрессии тканей.

3. Восстановление функциональной активности мышц

Интенсивная физическая работа, перегрузка нетренированных мышц, воздействие холода, рефлекторное напряжение при патологии внутренних органов, дистрофических изменениях позвоночника, нарушении двигательного стереотипа способствуют формированию боли за счет выраженного напряженного мышечного сокращения. Это приводит к повышению тонуса мышц и формированию порочного круга «боль - мышечный спазм - боль». У каждой мышцы имеются две регуляторные системы: мышечные веретена регулируют длину мышцы, а сухожильный орган Гольджи регулирует напряжение. В зависимости от методики тейпирования можно воздействовать на эти механизмы и регулировать мышечный тонус.

4. Нормализация функции суставов



Нервные волокна, иннервирующие мышцы и кожу в области сустава, также иннервируют ткани суставов. Поэтому активация рецепторов кожи способствует активации проприорецепторов мышц и суставов (кинестезия - ощущение положения частей тела). При нарушении двигательного стереотипа тейпирование помогает регулировать обратную связь, а постоянная стимуляция рецепторов обеспечивает длительный эффект. Тейп также может механически поддерживать сустав.

Показания к применению

Кинезиотейпирование целесообразно применять как самостоятельный метод, а также в сочетании с другими методами лечения.

Спортивная медицина

- Профилактика спортивных травм.
- Посттравматические болевые синдромы суставов.
- Ушибы мягких тканей.
- Растяжение связок.
- Сколиоз.

- Юношеский кифоз.
- Ахиллобурсит.
- Варусное искривление голеней у детей.

Неврология

- Проявления остеохондроза.
- Мышечно-фасциальные болевые синдромы.
- Гинекологические болезни.
- Нарушение лимфотока.
- Альгодисменорея.

Педиатрия

- Улучшение моторики у детей.

Противопоказания

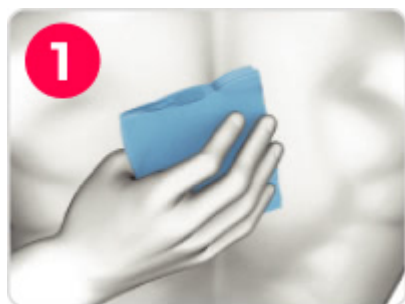
- Открытые раны и трофические язвы.
- Экзема.
- Аллергическая реакция на акрил.
- Ксеродерма.
- Первый триместр беременности.
- Индивидуальная непереносимость.

Разберем наложение тейпа при наиболее распространенных травмах и заболеваниях у любителей спорта.

Общие правила наложения тейпа

- Тейп накладывается без натяжения при сильной перегрузке или ушибе.
- В остальных случаях натяжение 10-75%.
- Мышцы должны быть растянуты (кроме гематом).
- Сначала основной слой, затем поддерживающие.
- Для тонизирующего эффекта - сверху вниз.
- Для расслабляющего - снизу вверх.

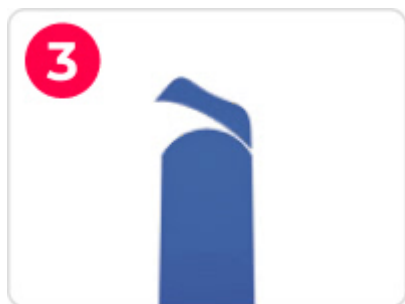
Подготовка к использованию



Наклеивайте на сухую и чистую кожу за 30 минут до нагрузки, при необходимости удалите волосы.



Отрежьте ленту нужной длины.



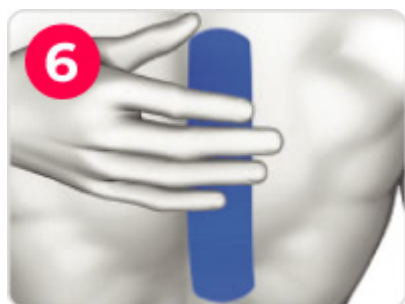
Закруглите края.



Края (2-5 см) не натягиваются.



Постепенно снимайте подложку и наклеивайте.



После наклеивания разотрите тейп рукой, для снятия используйте масло или горячую воду.

Растяжение связочно-мышечного аппарата голеностопного сустава

Вам понадобится три тейпа: 50 см и два по 15 см.

1. Сидя, угол 90°. Первый тейп от пятки до голени: сначала без натяжения, затем 40%, якоря без натяжения.
2. Второй и третий - кольцевые, натяжение 70%, якоря без натяжения.

Синдром илиотибиального тракта

Нужен тейп 50-55 см и два по 15-20 см.

1. Первый - снизу вверх с натяжением 10%.
2. Второй - под углом 90°, натяжение 70-80%.
3. Третий - выше второго, натяжение 70-80%.

Это несколько вариантов наложения простой аппликации тейпа.

При травме или болевом синдроме опорно-двигательного аппарата в первую очередь стоит обратиться к врачу, и более сложные аппликации должны выполняться специалистом.